REVISIÓN DE CASO
¿CONVULSIONES?

Elián Andrés Camacho Zafra
Médico Interno - UPTC

MOTIVO DE CONSULTA

"No respondía y se orinó"

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente femenina de 80 años, traída al servicio de urgencias por presentar cuadro clínico caracterizado por dos episodios sincopales, separados por un intervalo aproximado de 24 horas, presenciados por su hija. Los eventos iniciaron de forma súbita, en posición de sedestación, con desconexión del medio, giro cefálico derecho, pérdida del tono postural evidenciado por caída de objetos que sostenía en las manos, pérdida completa de la conciencia y relajación del esfínter vesical. Durante ambos episodios se observaron movimientos involuntarios de predominio tónico, sin desviación ocular ni mordedura lingüal. La recuperación de la conciencia fue espontánea, completa y sin confusión postictal. No se reportan pródromos autonómicos (palidez, diaforesis, náusea, sensación de inestabilidad o visión borrosa) ni otros síntomas premonitorios

02/02/2026

REVISIÓN POR SISTEMAS

- Generales: Niega fiebre.
- Cardiopulmonar: Tos ocasional seca, niega disnea, niega palpitaciones.
- Gastrointestinal: No refiere.
- Genitourinario: No refiere.
- Neurológico: No refiere.

EXAMEN FÍSICO

TA: 147/73 FC: 83 FR: 16 SAT: 93% T: 36°C G:15/15

- Alerta, consciente, orientada, sin alteraciones del contenido del pensamiento.
- Lenguaje espontáneo, coherente y comprensible; sin afasia, disartria.
- Pupilas isocóricas, reactivas a la luz y a la acomodación.
- Movimientos oculares conservados, sin nistagmo ni paresia ocular.
- No asimetrías faciales ni desviación lingual o palatina.
- Fuerza muscular globalmente conservada. No hay fasciculaciones, hipertono ni hipotonía.
- Sensibilidad superficial y profunda conservadas.
- Reflejos oteotendinosos presentes y simétricos.
- Diadococinesia normal, sin dismetría ni temblor intencional.
- No signos meníngeos, no rigidez de nuca.
- No evidencia de deficits focales.

ANTECEDENTES

Patológicos	-Hipertensión Arterial -Hipotiroidismo -Vértigo
Farmacológicos	- Telmisartan + Hctz 80/12.5/día - Amlodipino 10 mg/día - Levotiroxina 25 mg/día -Dimenhidrinato/no recuerda - Mylanta/a necesidad
Quirúrgicos	-Reemplazo Articular de Cadera Derecha -Histerectomía -Corrección Glaucoma Bilateral -Hemorroidectomia -Safenectomía Izquierda
Alérgicos	-Niega

PARACLÍNICOS DE INGRESO

Función Renal
BUN: 13 mg/dL
Creatinina: 0.65

Electrolitos
Sodio: 128 mmol/L
Potasio: 5 mmol/L
Cloro: 99.9 mmol/L

Hemograma
Leu: 11.550 uL
Neu: 86.6%
Linf: 6.9%
RBC: 4.330.000 uL
Hgb: 11.9 g/dL
Hcto: 36.2%
Plq: 336.000 uL

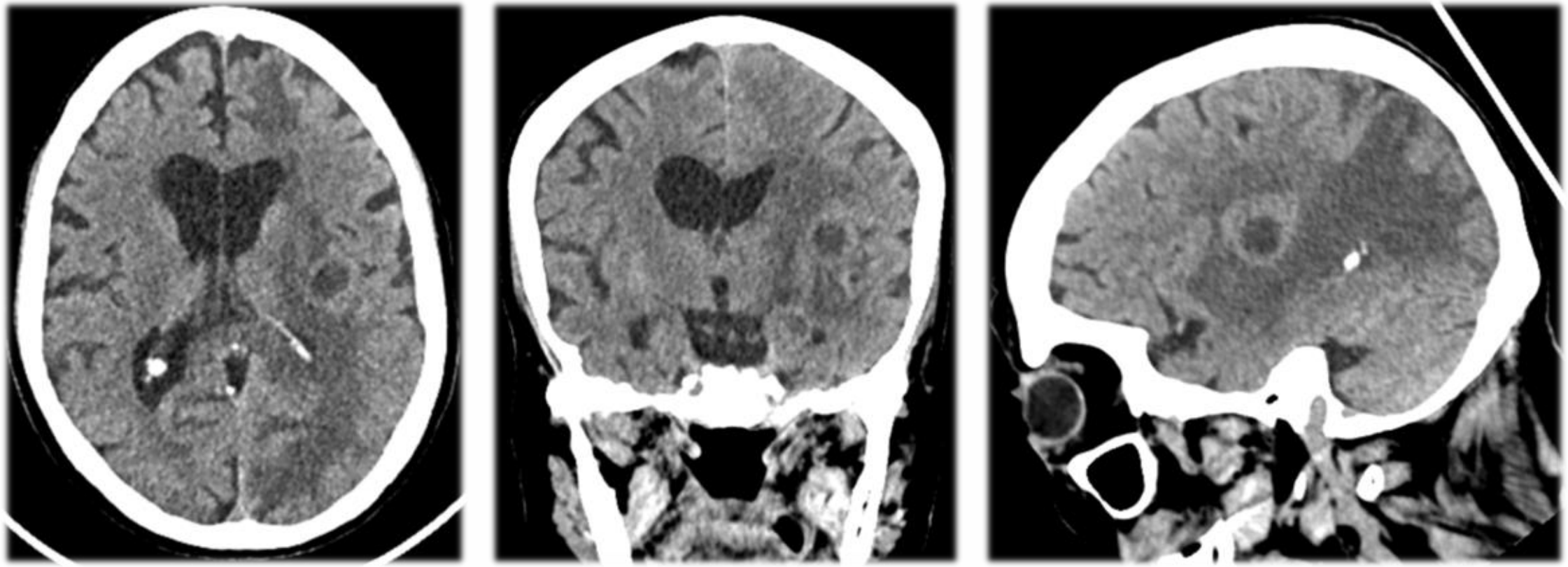
PARACLÍNICOS ADICIONALES

TSH: 1.29 uUl/mL
T4L: 1.40 ng/dL

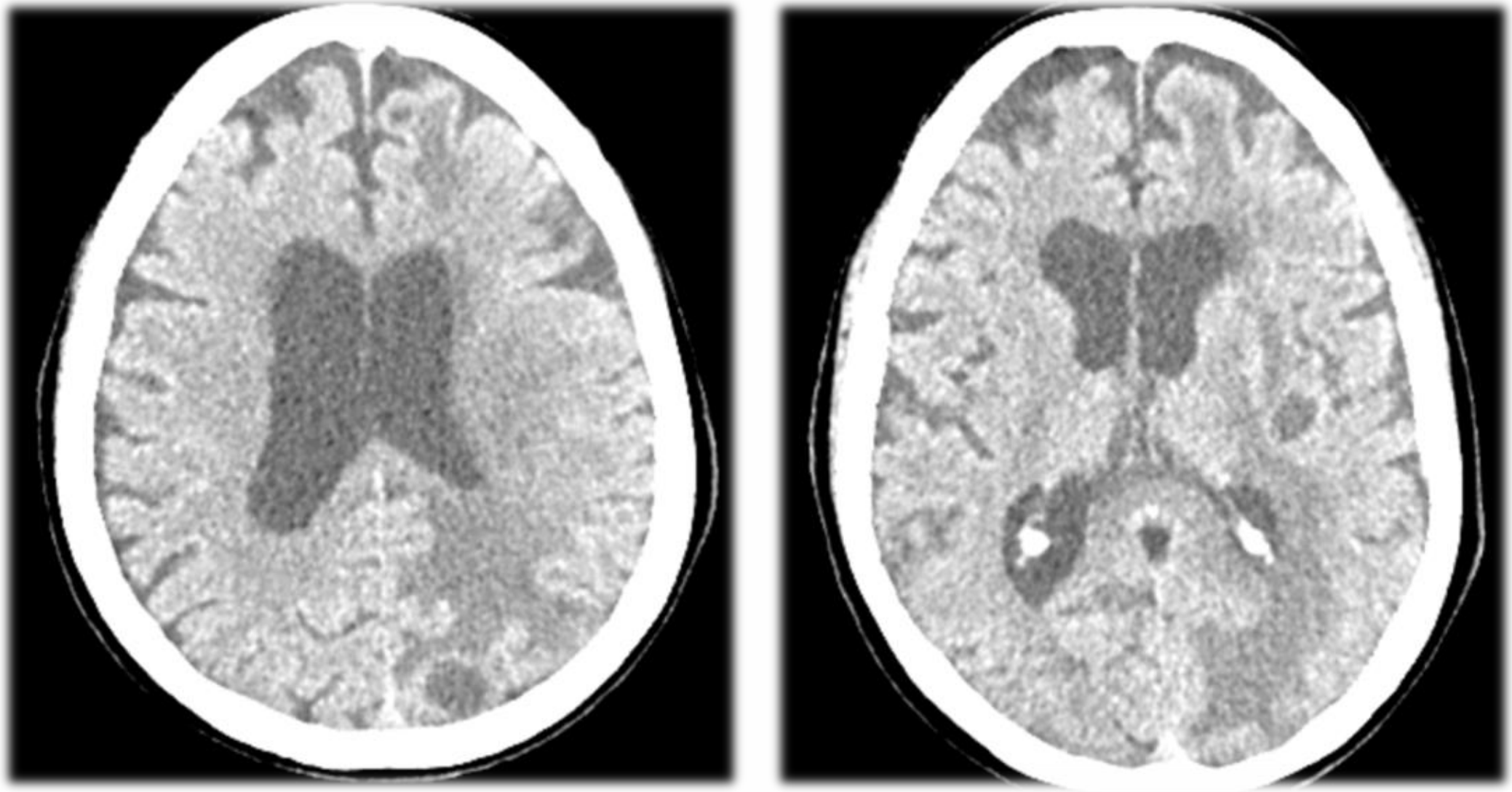
Uroanálisis

FÍSICO QUÍMICO
-Color: Amarillo
-Aspecto:Ligeramente turbio
-Glucosa: 0 mg/dl
-Proteínas: 0 mg/dl
-Bilirrubinas: 0 mg/dl
-Urobilinógeno: 2.0 mg/dl
-P.H: 6.0
-Densidad: 1.010
-Sangre: 0.03 mg/dL
-Cetonas: 0 mg/dl
-Nitritos: Negativo
-Leucocitos: 0 Leu/ul

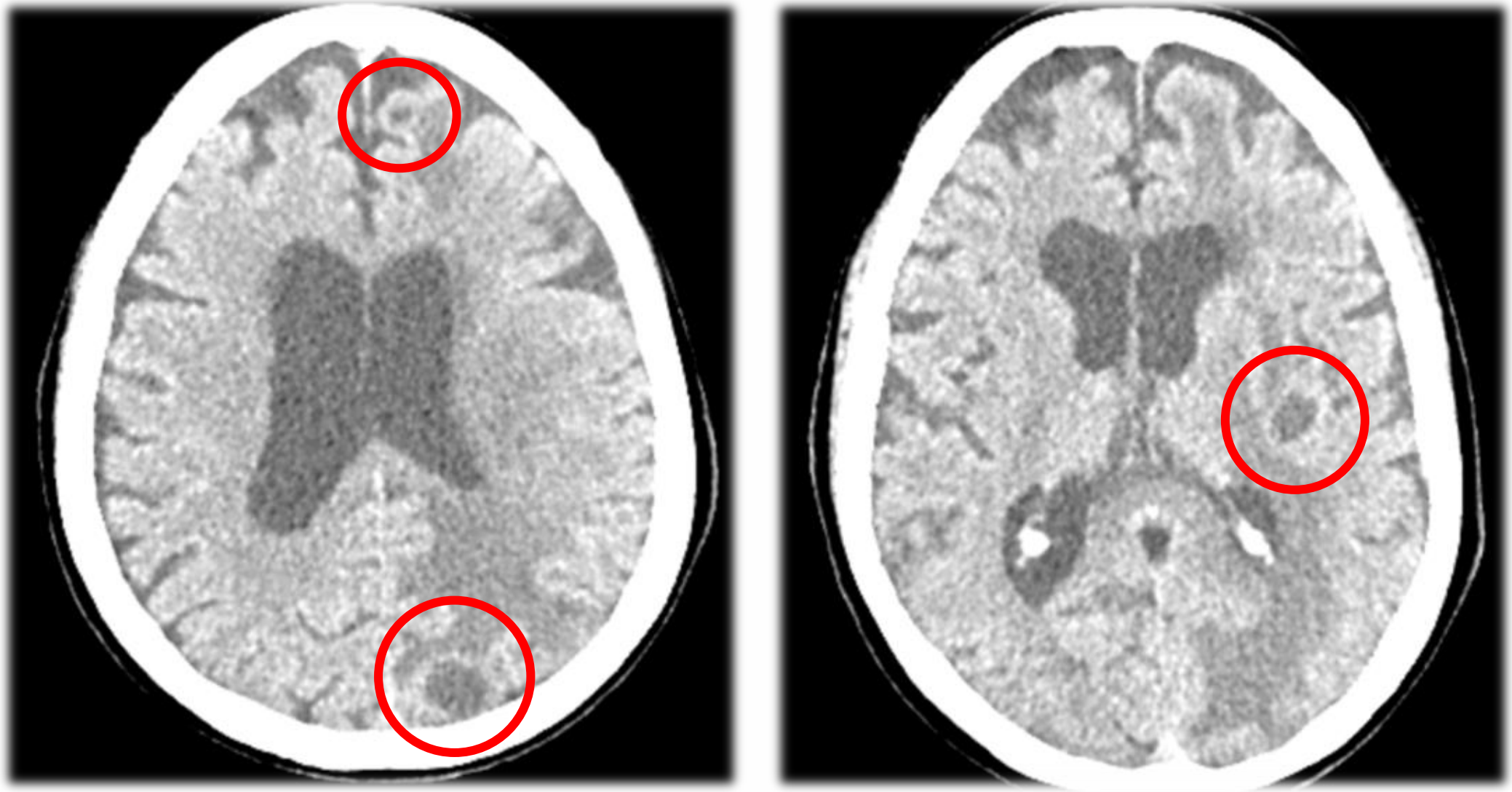
SEDIMENTO URINARIO
-Leucocitos: 2-5 xc
-Células Epiteliales Bajas: 2-4 xc
-Bacterias: + xc
-Hematíes: 0 xc
-Hematíes Fresco: 0



TAC DE CRANEO SIMPLE



TAC DE CRANEO CONTRASTADO



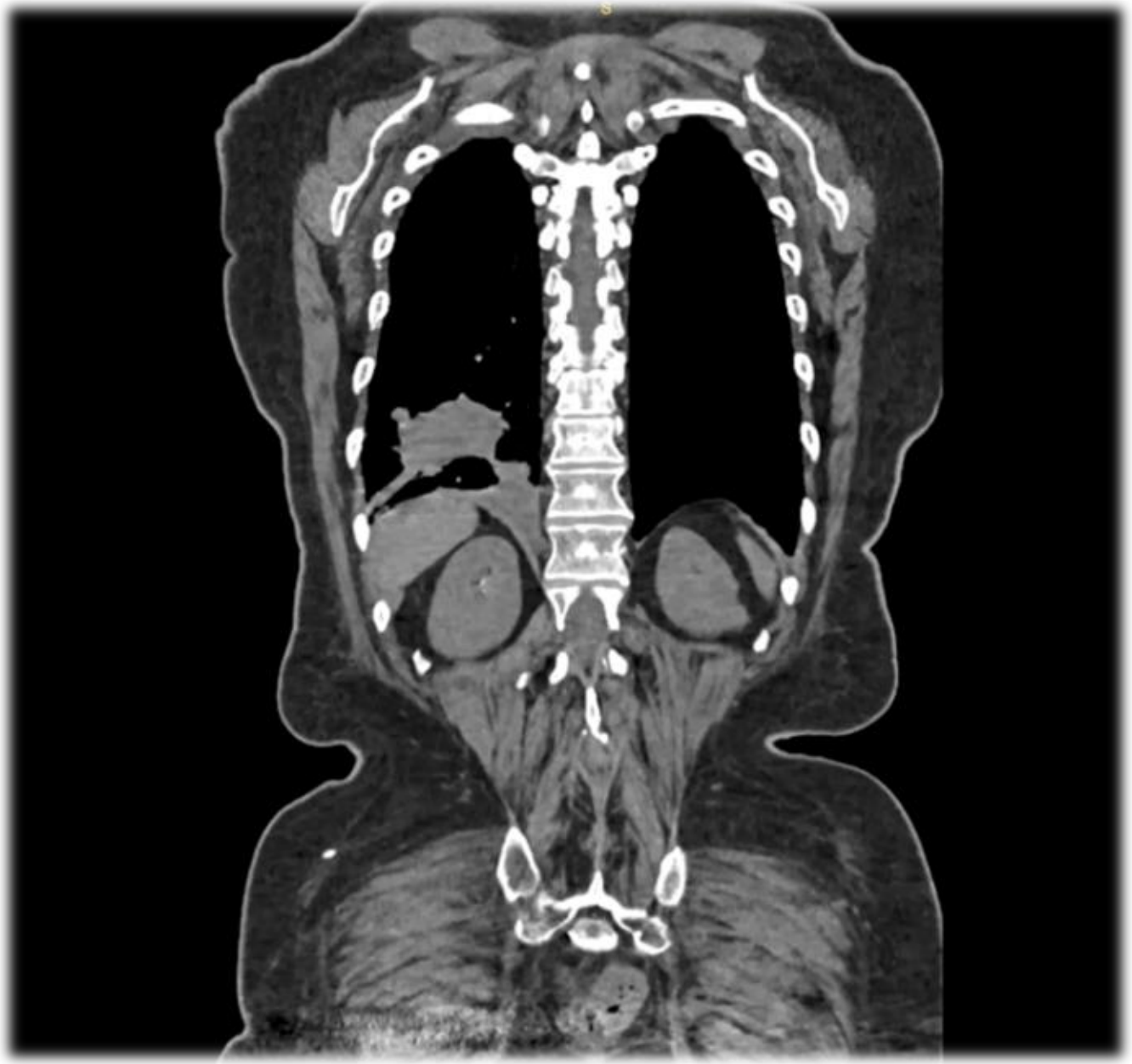
TAC DE CRANEO CONTRASTADO

RADIOGRAFÍA DE TORAX





TAC DE TORAX CONTRASTADO



TAC DE TORAX CONTRASTADO

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

1. Neoplasia en estudio
   -Sospecha de origen pulmonar
2. Sindrome convulsivo 1er episodio
   -Lesiones cerebrales secundarias?
3. Hiponatremia Euvolémica
   -Secundaria a uso de tiazidicos
4. Hipertensión Arterial
5. Hipotiroidismo

LÍNEA DE TIEMPO

MEDICINA INTERNA
Hiponatremia Moderada
Se inicia SSN 3% 30cc/h

Hiponatremia Moderada 2ria a uso de tiazídicos
Resuelta

NEUROLOGÍA
Crisis facilitada secundaria a estructuralidad
Solicitan RMN y VTM

-No se puede realizar RMN
-VTM → Encefalopatía 2rio a tx electrolítico

NEUROCIRUGÍA
Epilepsia focal estructural, ss/TAC-C
Se inicia Levetiracetam 1gr/12h
Dexametasona 8 mg/8h

-No presenta nuevos episodios consulsivos
-Lesiones en pulmón posible #1

MEDICINA INTERNA:
Biopsia de lesión de pulmón

Tumor epitelial de célula no pequeña con patrones sólido y acinar mucoproductor de alto grado nuclear

DIAGNOSTICOS

1. Tumor epitelial de célula no pequeña con patrones sólido y acinar mucoproductor de alto grado nuclear
2. Epilepsia Focal Estructural
   -Metástasis cerebrales
3. Hiponatremia euvolémica - Resuelta
4. Hipertensión Arterial controlada
5. Hipotiroidismo en suplencia

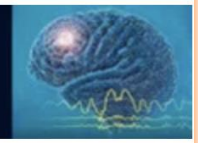
SINDROME CONVULSIVO

ASPECTOS GENERALES EN URGENCIAS

Elián Andrés Camacho Zafra

Médico Interno - UPTC

Epilepsia®
Official Journal of the International League Against Epilepsy



SPECIAL REPORT | Open Access

Updated classification of epileptic seizures: Position paper of the International League Against Epilepsy

Sándor Beniczky, Eugen Trinka, Elaine Wirrell, Fatema Abdulla, Raidah Al Baradie, Mario Alonso Vanegas, Stéphane Auvin, Mamta Bhushan Singh, Hal Blumenfeld, Alicia Bogacz Fressola, Roberto Caraballo, Mar Carreno, Fernando Cendes, Augustina Charway, Mark Cook, Dana Craiu, Birinus Ezeala-Adikaibe, Birgit Frauscher, Jacqueline French, M. V. Gule, Norimichi Higurashi, Akio Ikeda, Floor E. Jansen, Barbara Jobst, Philippe Kahane, Nirmeen Kishk, Ching Soong Khoo, Kollencheri Puthenveettil Vinayan, Lieven Lagae, Kheng-Seang Lim, Angelica Lizcano, Aileen McGonigal, Katerina Tanya Perez-Gosiengfiao, Philippe Ryvlin, Nicola Specchio, Michael R. Sperling, Hermann Stefan, William Tatum, Manjari Tripathi, Elza Márcia Yacubian, Samuel Wiebe, Jo Wilmshurst, Dong Zhou, J. Helen Cross ... See fewer authors

First published: 23 April 2025 | https://doi.org/10.1111/epi.18338 | VIEW METRICS

ILAE International League Against Epilepsy

8a edición
TINTINALLI
MEDICINA DE URGENCIAS

Review Article

Management of status epilepticus: a narrative review

I. Migdady,[1] E. S. Rosenthal[2] and H. R. Cock[3]

1 Fellow, Department of Neurology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
2 Assistant Professor, Massachusetts General Hospital, Department of Neurology, Divisions of Clinical Neurophysiology and Neurocritical Care, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
3 Professor and Consultant, Clinical Neurosciences Academic Group, Institute of Molecular and Clinical Sciences, St. George's University of London, London, UK

REVIEW ARTICLE · Volume 39, Issue 1, P87-102, January 2023

Status Epilepticus

A Neurologic Emergency

Patrick J. Coppler, PA-C [a] · Jonathan Elmer, MD, MS [a,b,c]

Neurocrit Care
https://doi.org/10.1007/s12028-025-02425-8

NEUROCRITICAL CARE SOCIETY

NCS GUIDELINES

Guidelines for Neuroprognostication in Critically Ill Adults with Status Epilepticus

Dominik Madzar[1*], Venkatakrishna Rajajee[2], Susanne Muehlschlegel[3], Katja E. Wartenberg[4], Sheila A. Alexander[5], Katharina M. Busl[6], Claire J. Creutzfeldt[7], Gabriel V. Fontaine[8], David Y. Hwang[9], Keri S. Kim[10], Dea Mahanes[11], Shraddha Mainali[12], Juergen Meixensberger[13], Oliver W. Sakowitz[14], Panayiotis N. Varelas[15], Christian Weimar[16], Thomas Westermaier[17] and Sara E. Hocker[18]

© 2026 The Author(s)

¿POR QUÉ CONVULSIONES?

MORTALIDAD:

1%

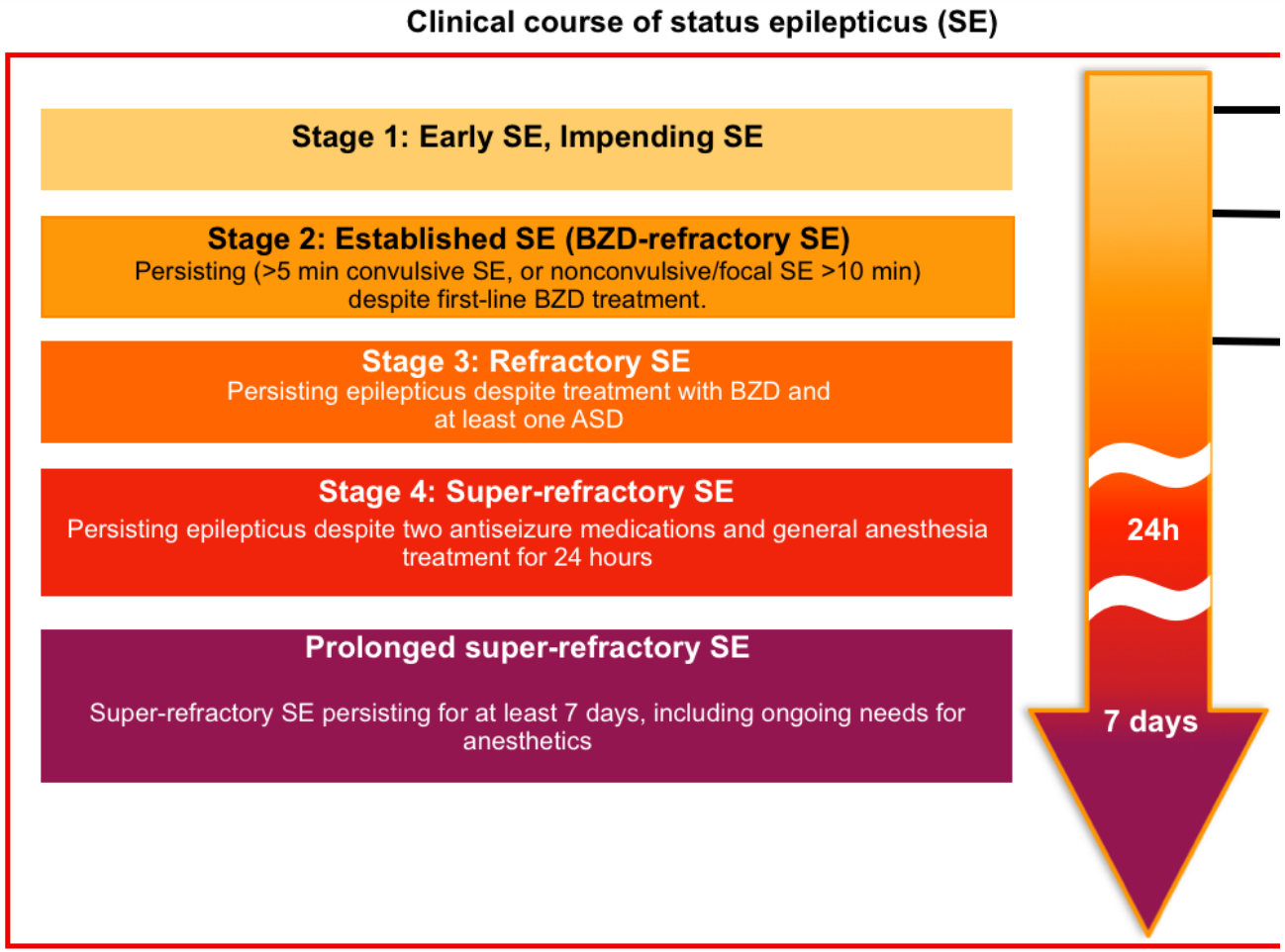
<5%

<20%

30%

40%

60%



ASD, antiseizure drugs; BZD, benzodiazepine. t1: the onset of abnormally prolonged seizure. t2: the onset of the long-term consequences.

DEFINICIONES

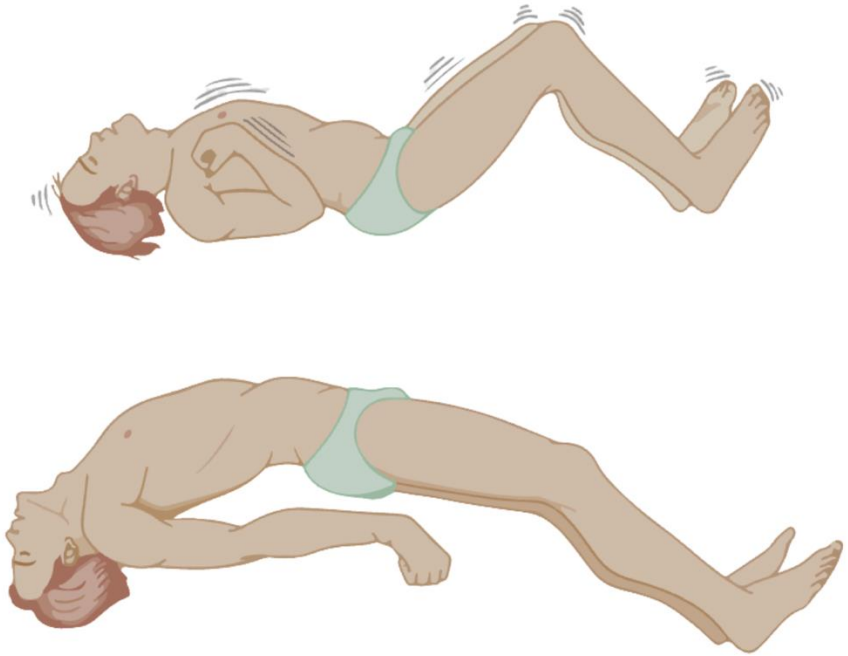
CONVULSIÓN:

-Episodio de disfunción cerebral secundario a alteración eléctrica → Evento aislado

-Contracciones musculares sostenidas o intermitentes, usualmente bilaterales y de duración variable.

Causas Principales:

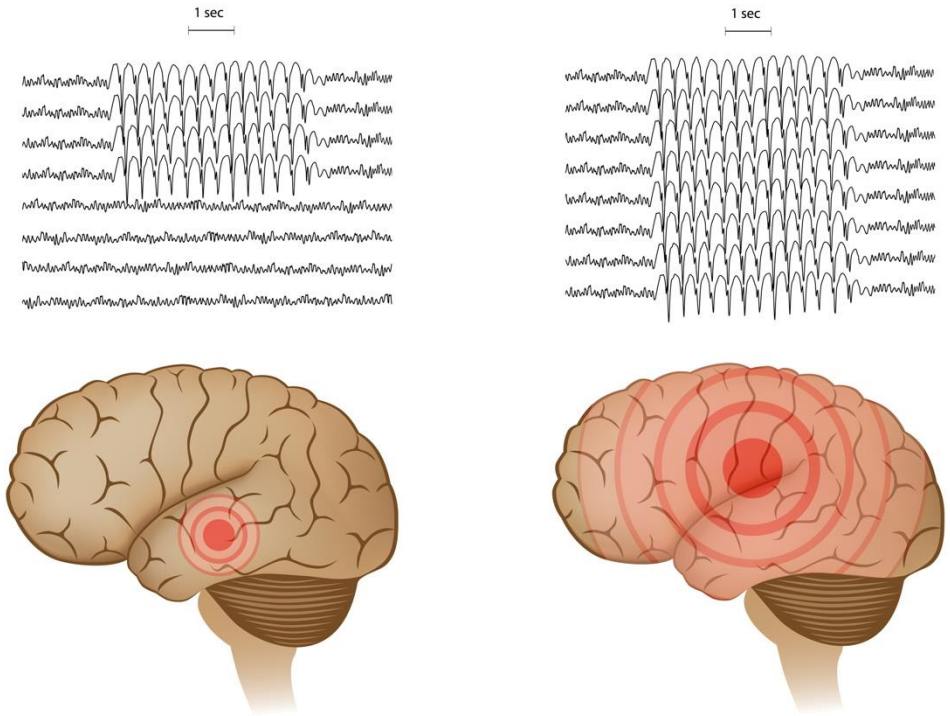
- Trauma Craneoencefálico
- Infecciones
- Abuso o Abstinencia a sustancias
- Desequilibrios Electrolíticos
- Tumores Cerebrales
- Idiopatico
- Fiebre (niños)



DEFINICIONES

EPILEPSIA: Enfermedad Crónica No Transmisible.

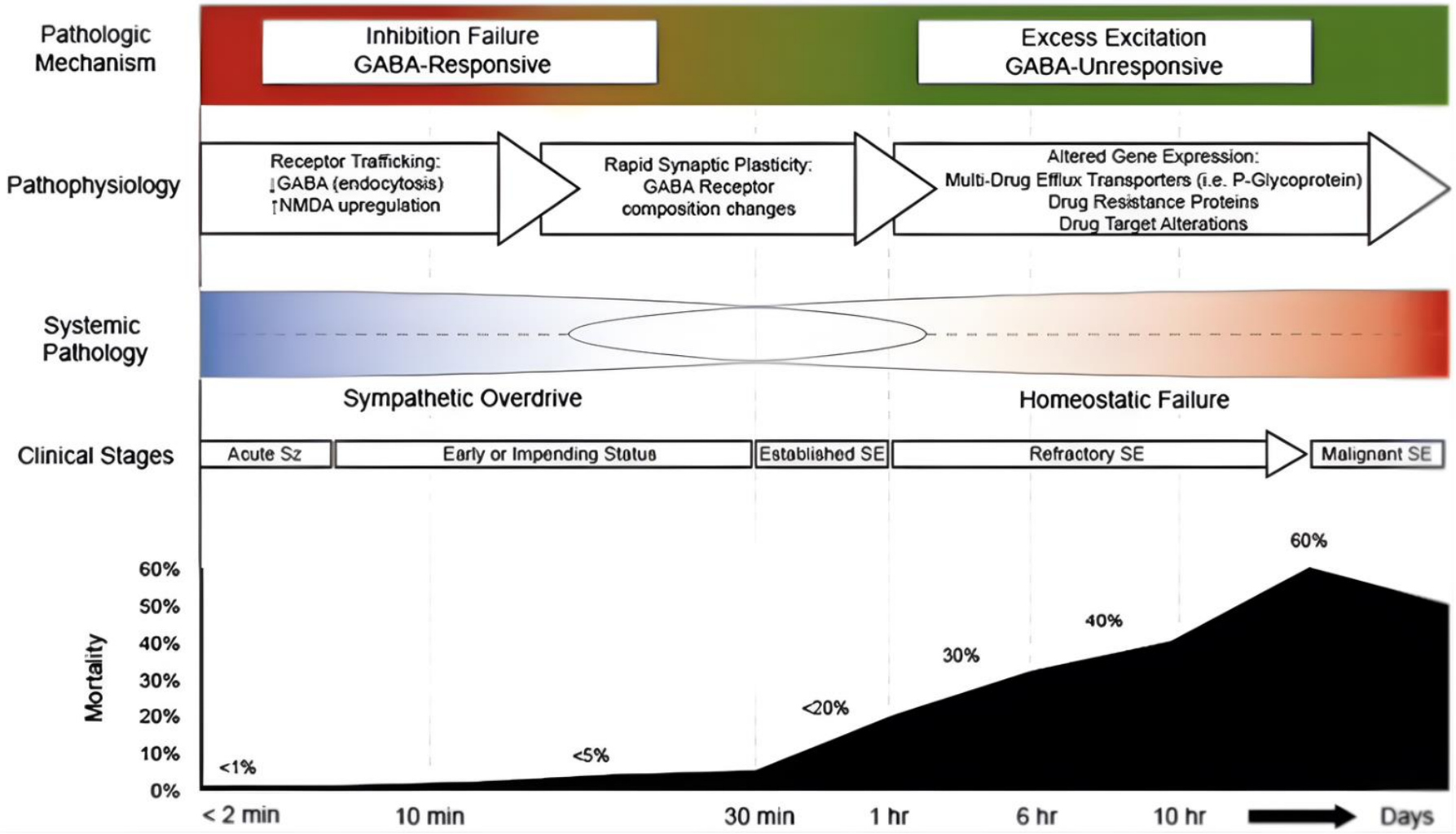
-2 convulsiones no provocadas con al menos 24h de diferencia
-1 episodio no provocado con alta probabilidad de presentar nuevas crisis en los siguientes 10 años



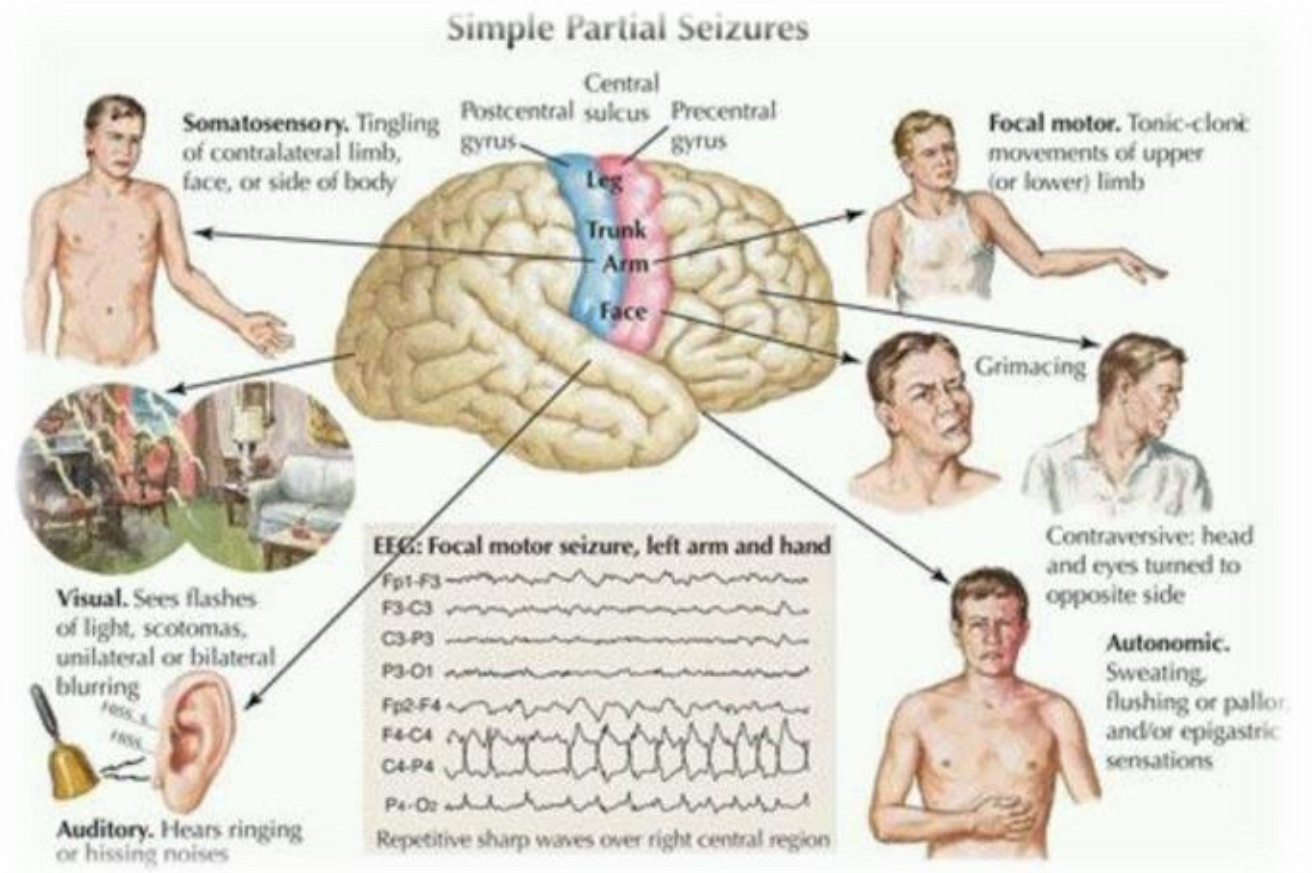
Partial seizure

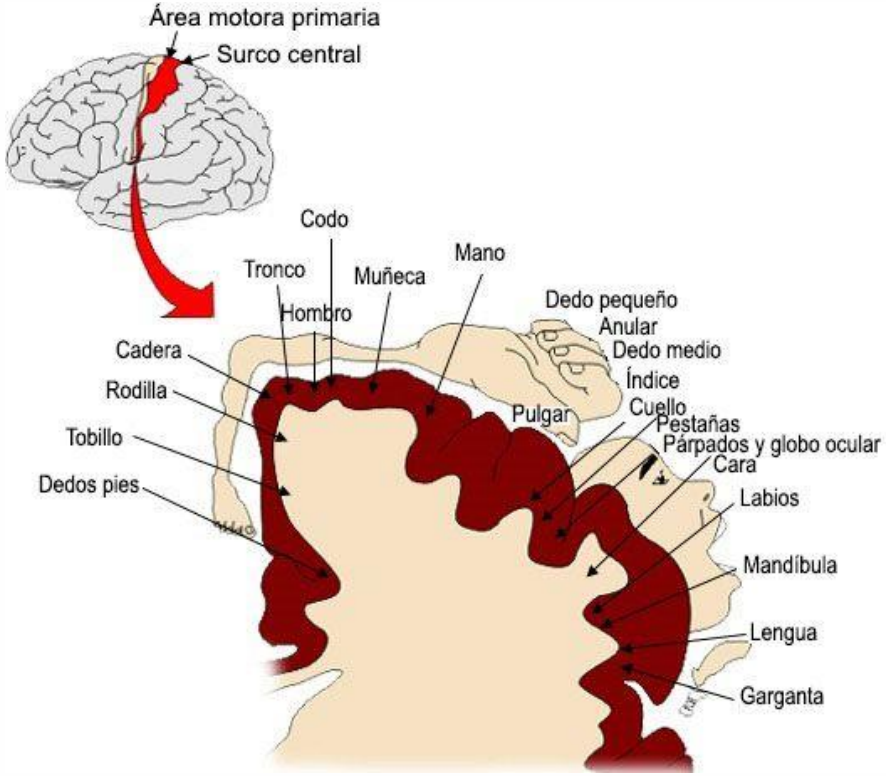
Generalized seizure

ESTATUS EPILEPTICO



CONVULSIÓN FOCAL





CONVULSIÓN GENERALIZADA



1. Fase tónica
("contracción muscular")



2. Fase clónica
("movimientos bruscos involuntarios")



3. postconvulsiva
("agotamiento")

El problema surge cuando no sucede el agotamiento y continua la convulsión.

CLASIFICACIÓN 2025

VERSION EXPANDIDA

Focal

Consciencia[1,2]
- *Preservada*
- *Alterada*

Crisis focal a tónico-clónica bilateral

Desconocida

si es focal o generalizada

Consciencia[1,3]
- *Preservada*
- *Alterada*

Crisis tónico-clónica bilateral

Generalizada

- Ausencia típica - Ausencia atípica - Ausencia mioclónica - Mioclonías palpebrales con / sin ausencia	- Mioclónica[5] - Clónica[5] - Mioclónica negativa[5] - Espasmos epilépticos[5] - Tónica[5] - Mioclónico-atónica - Atónica[5]

Crisis tónica-clónica generalizada
- Crisis mioclónico-tónico-clónica
- Ausencia a tónico-clónica

DESCRIPTORES EXPANDIDOS:
Descriptores semiológicos en secuencia cronológica[4] incluidos los espasmos epilépticos focales, mioclonía, tónico & clónico[4]

No clasificada

ABORDAJE

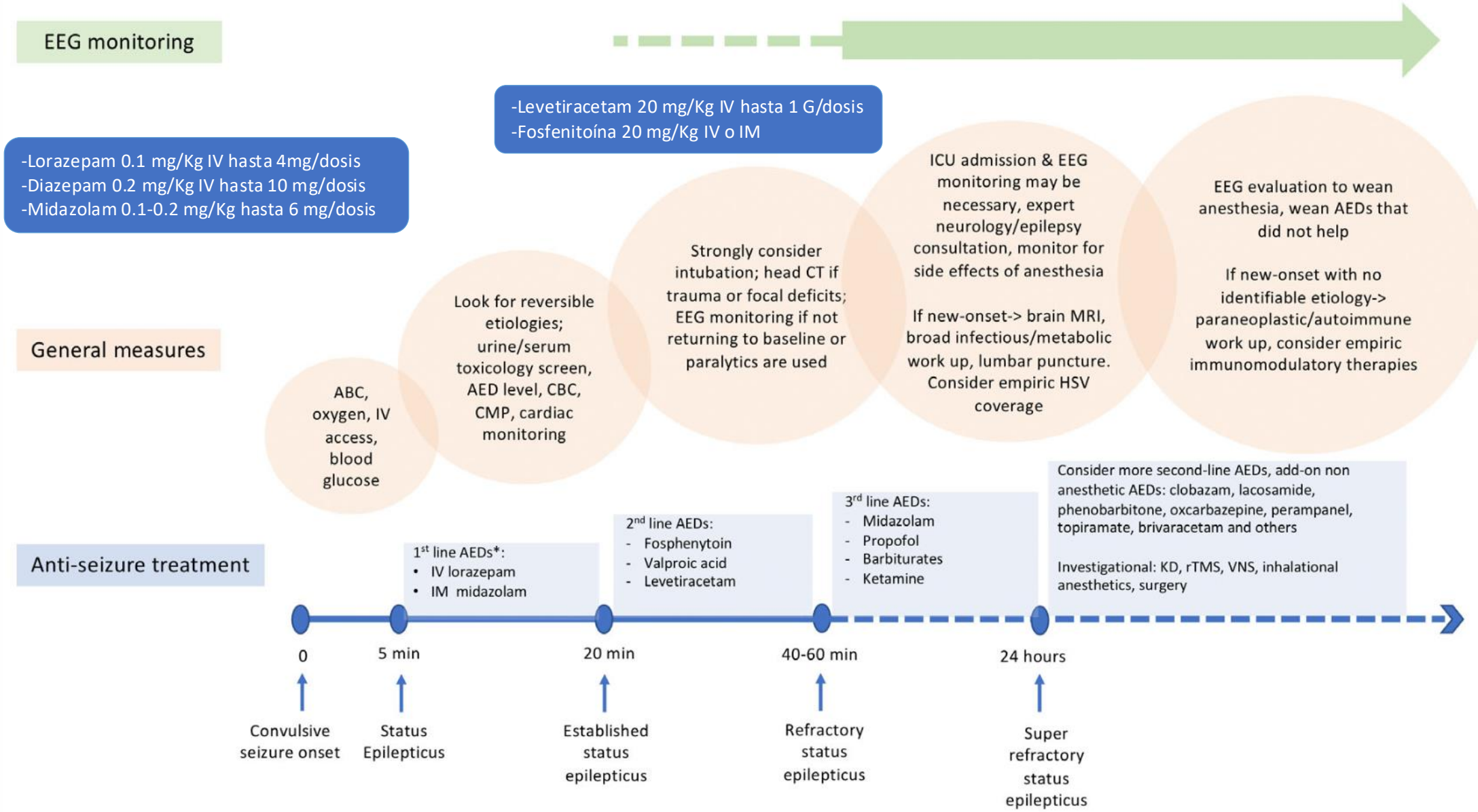
HISTORIA CLÍNICA → Descripción específica

-Temporalidad
-Síntomas premonitorios
-Contexto
-Características → Esfínteres, movimientos, desviación ocular
-Traumatismos
-Periodo postictal

Antecedentes

-Patologías sistémicas
-Patologías neurológicas
-Número de episodio
-Tratamientos previos
-Historia de tóxicos
-Alergias

MANEJO


EEG monitoring
-Levetiracetam 20 mg/Kg IV hasta 1 G/dosis
-Fosfenitoína 20 mg/Kg IV o IM
-Lorazepam 0.1 mg/Kg IV hasta 4mg/dosis
-Diazepam 0.2 mg/Kg IV hasta 10 mg/dosis
-Midazolam 0.1-0.2 mg/Kg hasta 6 mg/dosis
General measures
ABC, oxygen, IV access, blood glucose
Look for reversible etiologies; urine/serum toxicology screen, AED level, CBC, CMP, cardiac monitoring
Strongly consider intubation; head CT if trauma or focal deficits; EEG monitoring if not returning to baseline or paralytics are used
ICU admission & EEG monitoring may be necessary, expert neurology/epilepsy consultation, monitor for side effects of anesthesia
If new-onset-> brain MRI, broad infectious/metabolic work up, lumbar puncture. Consider empiric HSV coverage
EEG evaluation to wean anesthesia, wean AEDs that did not help
If new-onset with no identifiable etiology-> paraneoplastic/autoimmune work up, consider empiric immunomodulatory therapies
Anti-seizure treatment
1st line AEDs*:
• IV lorazepam
• IM midazolam
2nd line AEDs:
- Fosphenytoin
- Valproic acid
- Levetiracetam
3rd line AEDs:
- Midazolam
- Propofol
- Barbiturates
- Ketamine
Consider more second-line AEDs, add-on non anesthetic AEDs: clobazam, lacosamide, phenobarbitone, oxcarbazepine, perampanel, topiramate, brivaracetam and others
Investigational: KD, rTMS, VNS, inhalational anesthetics, surgery
0
5 min
20 min
40-60 min
24 hours
Convulsive seizure onset
Status Epilepticus
Established status epilepticus
Refractory status epilepticus
Super refractory status epilepticus

ETIOLOGÍA

CAUSE	FEATURES
Trauma	Intracranial bleed Concussion Skull fracture
Structural	Neoplasm Arteriovenous malformation Congenital malformation Hydrocephalus
Systemic	Hypertension Metabolic (eg, diabetes and ketoacidosis)
Infection	Meningitis Abscess Encephalitis Sinusitis Influenza Pyelonephritis Group A streptococcal pharyngitis
Toxic	Medication Ingestion

Causes of Acute and Remote Symptomatic Seizures

CAUSE	EXAMPLES
Fever (febrile seizure)	
• Infectious process	Meningitis, encephalitis, brain abscess
• Traumatic lesions	Cerebral contusion, hemorrhage (subdural, epidural, subarachnoid, intraparenchymal), impact seizure
Toxic conditions	Drug intoxication, drug withdrawal
Metabolic disturbances	Hypoglycemia, hyponatremia, hypernatremia, hypomagnesemia, hypophosphatemia, hepatic or renal disorder, inborn errors of metabolism (eg, aminoacidurias, organic acidurias, mitochondrial disease)
Neoplastic disease	
• Vascular disorders	Arteriovenous malformation, subarachnoid hemorrhage, intraparenchymal hemorrhage, cerebral venous thrombosis, ischemic infarct, hypertensive encephalopathy
• Neurocutaneous disorder	Neurofibromatosis, tuberous sclerosis, Sturge-Weber syndrome
Neurodegenerative disorders—miscellaneous	Hypoxia, ventriculoperitoneal shunt malfunction, cerebral palsy, cerebral dysgenesis, primary epilepsy

Gracias

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

ANA MARITZA DÁVILA BARÓN

GERENTE